

Protocolo de alta — Apendicectomía laparoscópica

Servicio de Cirugía General. Documento de referencia para el seguimiento telefónico durante los primeros catorce días tras la intervención.

Cuidado de la herida

La apendicectomía laparoscópica deja tres incisiones pequeñas: una en el ombligo y dos en la parte baja del abdomen. Mantenga los apósitos limpios y secos durante las primeras cuarenta y ocho horas. Pasado ese plazo puede retirarlos y ducharse con normalidad, dejando correr el agua sobre las incisiones sin frotarlas y secando después con una toalla limpia, a toquecitos.

No aplique cremas, pomadas, alcohol ni agua oxigenada sobre las incisiones salvo indicación médica expresa: retrasan la cicatrización y ocultan los signos de infección que precisamente queremos vigilar. Evite bañeras, piscinas y jacuzzis hasta que el cirujano retire los puntos.

Cómo curar la herida en casa

Si el cirujano le indicó curas diarias, siga estos pasos en orden:

1. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos.
2. Retire el apósito anterior tirando en paralelo a la piel, nunca hacia arriba.
3. Limpie cada incisión con suero fisiológico, de dentro hacia afuera, usando una gasa distinta para cada una.
4. Deje secar al aire un minuto sin soplar sobre la herida.
5. Coloque un apósito nuevo y anote en un papel cómo vio la herida ese día.

Si en algún paso observa pus, mal olor o separación de los bordes, detenga la cura y llame al equipo antes de continuar.

Medicación

El tratamiento al alta combina un antibiótico y un analgésico. No suspenda el antibiótico aunque se sienta bien: la pauta completa es lo que evita la infección del lecho quirúrgico.

Medicamento	Dosis	Pauta	Duración	Observaciones
Cefalexina	500 mg	cada 8 horas	7 días	Tomar con alimentos
Acetaminofén	1 g	cada 8 horas	5 días	No superar 4 g en 24 horas
Ibuprofeno	400 mg	cada 12 horas	si dolor	Solo si el acetaminofén no es suficiente
Omeprazol	20 mg	una vez al día	7 días	En ayunas, si toma antiinflamatorios

Si olvida una toma del antibiótico, tómela en cuanto se acuerde salvo que falten menos de dos horas para la siguiente. Nunca duplique la dosis para compensar.

Signos de alarma

Acuda al servicio de urgencias si presenta fiebre superior a 38.5 grados, sangrado activo por las incisiones, dehiscencia de la herida, dolor abdominal intenso que no cede con la analgesia pautada, vómitos persistentes que le impidan tolerar líquidos, o ausencia de gases y deposiciones durante más de setenta y dos horas acompañada de distensión del abdomen.

Enrojecimiento que se extiende alrededor de una incisión, secreción purulenta o un aumento del dolor a partir del cuarto día son signos de infección de la herida y requieren valoración el mismo día, aunque no haya fiebre.

Cuándo llamar al equipo

Si el dolor aumenta de forma progresiva durante más de veinticuatro horas.

Actividad

Camine desde el primer día en casa, en trayectos cortos y varias veces al día: la movilización temprana previene trombosis y ayuda a que el intestino recupere su ritmo. Suba escaleras despacio y sin cargar peso.

Evite levantar más de cinco kilos y los esfuerzos abdominales — abdominales, gimnasio, cargar niños en brazos — durante cuatro semanas. Puede conducir cuando sea capaz de hacer una frenada de emergencia sin dolor, lo que suele ocurrir entre el séptimo y el décimo día. La reincorporación laboral depende del tipo de trabajo: de siete a diez días en labores de oficina, de tres a cuatro semanas si implica esfuerzo físico.

Dieta

Empiece con líquidos claros y comidas ligeras en pequeñas cantidades y aumente según tolerancia. La mayoría de los pacientes vuelve a su dieta habitual en tres o cuatro días.

Beba al menos dos litros de agua al día e incorpore fruta, verdura y cereales integrales: los analgésicos opioides y la propia cirugía estriñen, y hacer fuerza en el baño es justo lo que conviene evitar durante las primeras semanas. Si al tercer día no ha tenido deposición, consúltelo en la llamada de seguimiento.

Cita de control

La revisión de la herida y el retiro de puntos se programan a los siete días de la intervención en el consultorio indicado en su hoja de alta. Acuda aunque se encuentre perfectamente: la valoración de la cicatriz no se puede hacer por teléfono.